جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : نجوى كمال زهران عطيه
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** حلوان **العنوان :** 0
رقم البطاقة : 26506100103302 **رقم التليفون :** 01126754507 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 20-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 10-06-1965 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالجلد
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالجلد
خطة العلاج : أورام كيماوي علاج تدعيمي وتلطيفي [6522] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نجوى كمال زهران عطيه
National ID: 26506100103302

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

A patient of skin cancer for Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	**الوقت :** -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٠١١٢٦٧٥٤٥٠٧
٠١١٤٠٦٥٣٩٩٧



Name :	Nagwa Kamal Zahran
Date :	January 22, 2026

HIGH RESOLUTION US OF THE INGUINAL REGIONS:

- The clinically felt swelling seen at the left sided inguinal region corresponding sonographically to two well defined hypoechoic lesions the largest an oblong shaped with faint rim vascularity measuring 3.2x2.7 cm &the second is rounded measuring 1.7x1.7cm with no vascularity uptake on color map ?? pathological lymph nodes/abscess for further assessment by MRI with contrast .
- Left inguinal region showing few inflammatory lymph nodes.
- Normal right inguinal region with few inflammatory lymph nodes.

Dr. Noura Youssef

Name: نجوى كمال زهران عطيه	
MR. : 11607	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 61-year-old individual with performance status 1 who presented with a 2 cm left gluteal region lesion at the site of a nevus and an associated left inguinal lymph node measuring approximately 3 × 3 cm. Staging investigations including CT of the chest, abdomen, and pelvis as well as a bone scan were ordered.

The patient has a history of hypertension and no family history of malignancy. A progressively enlarging left inguinal swelling was noted, and ultrasound performed on 22 January 2026 demonstrated two well-defined hypoechoic inguinal lesions measuring 3.2 × 2.7 cm and 1.7 × 1.7 cm, with further increase in size by June 2026. A pigmented fungating skin lesion with multiple surrounding pigmented nodules developed over the left gluteal region. Contrast-enhanced CT of the chest, abdomen, and pelvis on 20 July 2026 revealed innumerable bilateral pulmonary metastatic nodules (largest 32 × 26 mm in the posterior segment of the right upper lobe), tiny osteolytic lesions in the L4 and L5 vertebral bodies, a small enhancing metastatic nodule near the inferior angle of the right scapula, and hypovascular hepatic lesions in segments VI and III suspicious for metastases. Histopathology of a left inguinal lymph node biopsy showed extensive tumor necrosis with few viable malignant epithelioid cells containing brown pigment; immunohistochemistry was diffusely positive for S100, weakly positive for SOX10, focally positive for cytokeratin, and negative for P63 and HepPar-1, consistent with malignant melanoma with extensive necrosis. A re-biopsy was recommended for definitive diagnosis and molecular profiling.

Multidisciplinary team discussion on 19 August 2026 resulted in ordering BRAF mutation testing. Treatment was initiated with pembrolizumab (non-governmental organization supply) in combination with zoledronic acid (Zometa) administered every three months.

A surgical consultation was requested for a repeat biopsy because the initial pathology report was insufficient for molecular profiling and only a few viable cells were present. The plan is to obtain an adequate tissue sample to allow comprehensive molecular analysis.

تحريرا في ,

التاريخ :	20-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : يمنى امجد خالد

يعتمد ,

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

Date Of Submission: مراجعة ٨-١٠

Date Of MDT: 08/30/2026 10:49:10

Medical Report

Patient Name :	NAGWA كمال زهران عطيه	**Age :**	61 Y
Sex :	◉ Male ○ Female	**Comorbidity :**	HTN
ID No. :	11607	**Telephone :**	01140653997
Family History :	NAD	**Marital Status :**	◉ Married ○ Divorced ○ Single
Menopausal Status :	26506100103302	**Reason of MDT :**	ReMDT
		MDT name::	

Medical Report

Diagnosis : metastatic Cutaneous melanoma ,

Notes :

History: 61-year-old female , HTN . no family H/O of malignancy , PS1 The patient presented with a progressively enlarging left inguinal swelling. * US (22/01/2026): Left inguinal region showed two well-defined hypoechoic lesions: 3.2 × 2.7 cm, 1.7 × 1.7 cm Progressive increase in the size of the left inguinal LN *6/2026 >>> Development of a pigmented fungating skin lesion over left gluteal region, associated with multiple surrounding pigmented cutaneous nodules. CT CAP (20/07/2026): * Multiple innumerable bilateral pulmonary metastatic nodules, largest 32 × 26 mm in the post segment of the right upper lobe. * Tiny osteolytic lesions : L4 and L5 vertebral bodies metastases.? * Tiny enhancing sc metastatic nodule opposite the inferior angle of the right scapula. * Small hypovascular hepatic lesions in segments VI and III, suspicious for metastatic deposits 8/2026 >>> (Left inguina LN BX): * Extensive tumor necrosis with few viable malignant epithelioid cells containing brown pigment. * IHC: * S100: Diffusely positive , SOX10: Weakly positive, CK: Focally positive, P63: Negative, HepPar-1: Negative. * malignant melanoma + extensive necrosis. * Rebiopsy recommended

Investigations:

Recommendations: Rebiopsy from lesion couldn't be done by intervention radiology for possibility of excision

MDT DECISION: For excision for path confirmation and palliation

Specialty	Surgery	Pathology	Radiology